CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche V - C - 15

Version 2.0.0

Du 01/09/2026

TECHNIQUES ET MATÉRIELS

Rédacteurs :

Daniel MEYRAN

Julien PAPOZ

Olivier BALAN

Danis LARGER

Compressions thoraciques à deux doigts

INDICATIONS

Nourrisson de moins de 1 an ou nouveau né en arrêt cardiaque (Fiche IV-B-7).

Nourrisson de moins de 1 an qui a perdu connaissance à la suite d'une obstruction complète des voies aériennes (Fiche IV-B-1).

Nouveau-né qui présente une détresse à la naissance (fréquence cardiaque < 60 battements par minutes) (Fiche IV-B-8).

JUSTIFICATION

Quand le cœur s'arrête de fonctionner (ou bat très lentement chez le nouveau-né), le sang ne circule plus et la distribution d'oxygène n'est plus assurée. La compression régulière du thorax rétablit une circulation artificielle. Ce débit est suffisant pour maintenir le cerveau et le cœur de la victime oxygénés, notamment pendant les quelques minutes nécessaires à la mise en œuvre du choc électrique externe.

La pression, exercée au milieu de la poitrine d'une victime allongée sur le dos, vide les cavités cardiaques et les poumons du sang qui s'y trouve, et le propulse vers les organes périphériques.

Lorsque la pression est relâchée, la poitrine revient à sa taille initiale, le sang est de nouveau aspiré et remplit le cœur et les poumons. Ce sang sera ensuite propulsé par la compression thoracique suivante.

Lors d'un arrêt cardiaque consécutif à une obstruction complète des voies aériennes, les compressions thoraciques facilitent l'expulsion du corps étranger en élevant la pression qui règne à l'intérieur du thorax (effet de piston).

MATÉRIEL

Aucun matériel spécifique

RÉALISATION

- Placer le nourrisson ou le nouveau-né en position horizontale, sur le dos, sur un plan dur.
- Se placer au plus près du nourrisson ou du nouveau-né.
- Dénuder la poitrine.
- Placer la pulpe des deux pouces l'un sur l'autre, sur la moitié inférieure du sternum (fig. 1), la pointe des doigts vers la tête du nourrisson,;
- Englober le thorax du nourrisson avec les autres doigts de chaque main (fig. 2).
- Réaliser des compressions successivement avec les deux pouces. Les compressions doivent être d'environ 1/3 de l'épaisseur du thorax du nourrisson ou d'environ 4 cm et d'une fréquence d'environ 100 compressions par minute sans dépasser 120.
- Assurer un temps de compression égal au temps de relâchement.
- Les mains restent en place entre deux appuis et les doigts qui compriment relâchent complètement le thorax pour que celui-ci reprenne sa dimension initiale après chaque compression.

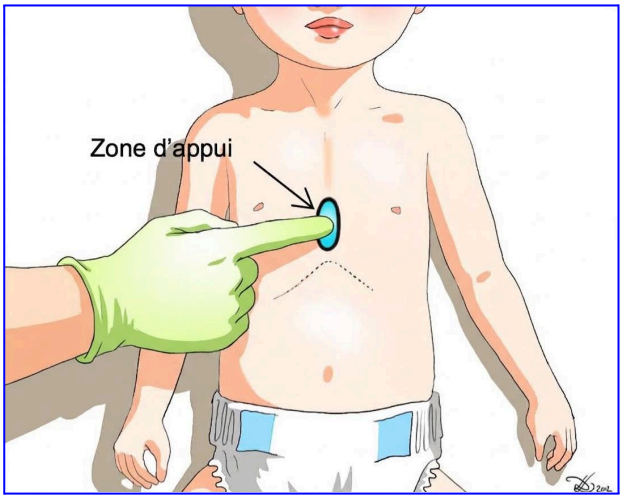


Figure 1 : zone d'appui

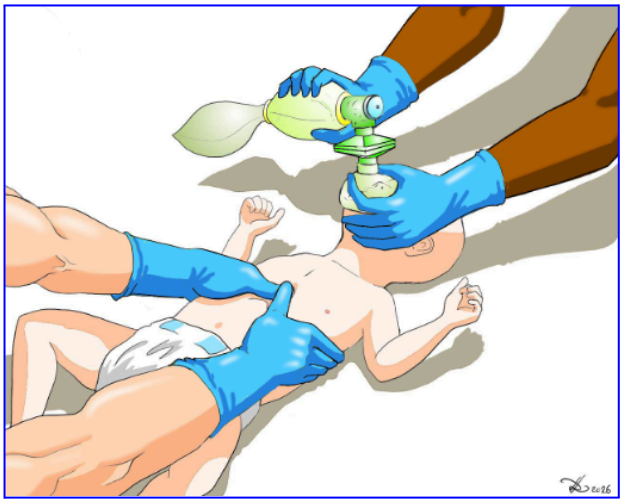


Figure 2 : compressions thoraciques à l'aide des deux pouces (nourrisson et nouveau-né)

RISQUES & CONTRAINTES

Une mauvaise position de la main, une compression thoracique trop forte ou non verticale peut entraîner des lésions du thorax (fractures de côtes) et des poumons (contusions).

Ces risques ne doivent pas faire diminuer la vigueur des compressions thoraciques. La présence d'une ventilation agonique ne doit pas faire interrompre les compressions thoraciques.

ÉVALUATION

L'efficacité des manœuvres de réanimation s'évalue sur :

- la reprise d'une ventilation normale,
- la recoloration de la victime,
- la perception d'un pouls lors des compressions thoraciques (à rechercher de préférence au niveau du pouls fémoral pour ne pas gêner la RCP),
- la récupération d'un corps étranger dans la bouche de la victime si l'AC est secondaire à une obstruction des voies aériennes par corps étranger.

Notes :